



表 36 ECMO 每日检查记录单 (C)

姓名		病案号		日期	20__年__月__日
年龄	__岁	床	__床	模式	☐ VA ☐ VV ☐ ECPR ☐ VAV ☐ 其他
上机时间	__月__日__时	已运行	__天__小时	班次	☐ 白班 ☐ 夜班
C 模块：患者临床状态（每班必查）					
C1. 神经系统					
检查项目	测量值		预警/异常→处理		
双侧瞳孔	左__mm /右__mm,光反射 ☐ 灵敏 ☐ 迟钝 ☐ 消失		双侧不等大、光反射消失、NPi<3→头颅 CT		
GCS 评分	E__ V__ M__ =__ 分		GCS 下降≥2 分→查中枢原因		
RASS 镇静评分	__ 分（目标 -1~-2）		过深(-4/-5)→减量镇静;过浅(+1~+4)→追加镇静		
NIRS（脑氧）（如有）	左__% /右__%,基线__%		rSO ₂ <50%或↓>20-25%基线→查 MAP/血气/Hb,必要时 CT		
肢体活动/癫痫样动作	☐ 正常 ☐ 偏瘫 ☐ 抽搐 ☐ 肌张力异常		新异常→评估是否需要 cEEG		
C2. 呼吸系统					
检查项目	测量值		预警/异常→处理		
呼吸机模式/参数	模式__ VT__ mL, PEEP__ RR__ FiO ₂ __ %		参照肺保护通气: VT 4-6mL/kg PBW, Pplat≤25cmH ₂ O		
自主呼吸/人机同步	☐ 同步 ☐ 对抗 ☐ 无自主		人机对抗→评估镇静、呼吸机设置		
痰液性状	☐ 白/清 ☐ 黄/脓 ☐ 血性 ☐ 粉红色泡沫		粉色泡沫痰→警惕肺水肿/左心淤血(VA)		
C3. 循环系统					
检查项目	测量值		预警/异常 → 处理		
MAP(平均动脉压)	__ mmHg		MAP<65mmHg→评估容量/流量/血管活性药		
脉压(PP)-VA 模式重点	__ mmHg		PP<10mmHg 或脉搏波呈平线→左心射血低/主动脉瓣未开→减流量/正性肌力/左心减压		
心率/心律	__ bpm ☐ 窦性 ☐ 房颤 ☐ 其他__		恶性心律失常→抗心律失常药/电复律		
血管活性药	去甲__ μg/kg/min, 多巴酚丁胺__ 其他__		剂量持续升高→病情恶化或管路功能异常		
SvO ₂ /ScvO ₂	__ %		<60%→氧输送不足(流量/Hb/SaO ₂); <70%→需关注趋势		
C4. 出凝血					
检查项目	测量值		预警/异常→处理		
口腔/鼻腔/气道渗血	☐ 无 ☐ 少量 ☐ 明显		明显出血→调整抗凝+局部止血		
穿刺点/引流管渗血	☐ 无 ☐ 少量 ☐ 明显		同上		
消化道出血	☐ 无 ☐ 胃管出血 ☐ 黑便		消化道出血→减/停抗凝+PPI+评估		
皮肤瘀斑/血肿	☐ 无 ☐ 少量 ☐ 大面积		大面积瘀斑→评估抗凝强度, 排查 DIC		
C5. 床旁超声（参见超声 SOP 打卡单·第二阶段；频率：VA q12h、VV q24h、ECPR q6h）					
检查项目	测量值		预警/异常→处理		
今日超声是否完成？	☐ 已完成 ☐ 未做（原因__）		运行期每日必须完成 1 次		
VA 模式重点(表 22·E)	LVEF__ % /LVDd__ mm; AV 开放 ☐ 是 ☐ 间隔 ☐ 否;心包 ☐ 无 ☐ 有__ mm		LV 增大/AV 持续关闭/心包增多→通知上级		
VV 模式重点(表 29)	肺部: ☐ A 线 ☐ B 线 ☐ 实变<右心 TAPSE__ mm		实变无改善→查原因, TAPSE<14→右心衰预警		

依据：ELSO 指南（2021-2024+ELSO 抗凝指南（2021）+ELSO 神经监测共识（2024）+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB 指南（2024）。用途：每班（白班/夜班）床旁逐项核对，异常项记录处理措施